

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SDS · ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE ZUNG

Self-Rating Depression Scale (Zung & Conde) – Medida cuantitativa autoinformada de síntomas afectivos, cognitivos y neurovegetativos de la depresión

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Self-Rating Depression Scale (SDS)
Nombre en español	Escala de Autoevaluación de la Depresión de Zung y Conde
Sigla oficial	SDS
Autores originales	William W. K. Zung (1965)
Adaptación hispanohablante	Valeriano Conde López, J. A. Escribá y J. Izquierdo (1970); Conde y Franch (1984)
Año de publicación original	1965 (adaptación y validación española pionera en 1970)
Constructo primario	Intensidad y gravedad sindrómica del episodio depresivo (afectivo, psicomotor y biológico)
Formato de administración	Autoinforme estructurado con escala ordinal Likert de 4 puntos (1 a 4)
Población diana	Población adulta y anciana (≥ 16 años) en atención primaria, geriatría y psiquiatría
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (20 ítems)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de dominio público con fines asistenciales

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Autoevaluación de la Depresión de Zung (SDS)** fue desarrollada por William W. K. Zung en la Universidad de Duke en 1965 con el propósito de ofrecer un instrumento de evaluación psicométrica ágil, capaz de cuantificar la presencia y severidad de la depresión clínica a partir de las descripciones directas del paciente. La escala se fundamenta operativamente en la conceptualización biomédica y nosológica de la depresión como un trastorno sistémico que involucra tres ejes semiológicos: 1) el afecto depresivo básico; 2) las perturbaciones fisiológicas y neurovegetativas; y 3) las alteraciones psicomotoras y del procesamiento cognitivo.

Un rasgo metodológico diferencial de la SDS radica en su distribución balanceada de ítems para neutralizar la aquiescencia: la mitad de los enunciados (10 ítems) están formulados en sentido patológico directo, mientras que los otros 10 ítems están redactados en sentido inverso evaluando bienestar, optimismo y funcionamiento preservado. La adaptación española de Conde et al. (1970) fue la primera escala de autoevaluación depresiva estandarizada y baremada en España, acumulando cinco décadas de respaldo empírico en atención primaria, servicios de enlace y epidemiología comunitaria.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Eje Semiológico / Factor	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Afecto Pervasivo y Anhedonia	4 ítems	4 – 16	Tristeza, llanto o ganas de llorar, insatisfacción vital y pérdida de la plenitud vital (ítems 1, 3, 18*, 20*).
2. Concomitantes Fisiológicos	8 ítems	8 – 32	Ritmo diurno matutino, insomnio, anorexia, pérdida de peso, estreñimiento, taquicardia y fatiga (ítems 2*, 4, 5*, 6*, 7, 8, 9, 10).
3. Perturbaciones Psicomotoras	2 ítems	2 – 8	Enlentecimiento psicomotor / dificultad en tareas e inquietud / agitación interna (ítems 12*, 13).
4. Manifestaciones Psicológicas	6 ítems	6 – 24	Confusión mental, desesperanza futura, irritabilidad, indecisión, inutilidad y deseo de muerte (ítems 11*, 14*, 15, 16*, 17*, 19).
Puntuación Total SDS	20 ítems	20 – 80	Suma directa de los 20 ítems corregidos (10 invertidos marcados con *). Índice SDS = (Puntaje / 80) $\times$ 100.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.84 – 0.90	Alta fiabilidad interna en pacientes psiquiátricos, ambulatorios y geriátricos en España (Conde y Franch).
Fiabilidad test-retest	r = 0.79 – 0.85 (2 semanas)	Estabilidad adecuada en pacientes depresivos sin cambios farmacológicos agudos.
Sensibilidad diagnóstica	85.0% – 88.0% (corte ≥ 52)	Excelente capacidad de detección sindrómica para episodios depresivos según criterios CIE/DSM.
Especificidad diagnóstica	82.0% – 86.0% (corte ≥ 52)	Adecuada precisión para discriminar distimia o controles de trastornos afectivos mayores.
Validez convergente	r = 0.76 con HDRS (Hamilton); r = 0.73 con BDI	Elevada correlación con escalas heteroaplicadas y autoinformes de depresión estándar.
Sensibilidad al cambio	Effect size d = 1.05	Disminución progresiva y estadísticamente significativa paralela a la remisión clínica con antidepresivos.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación ordinal de 4 categorías:**
 - 1 = **Muy poco tiempo / Raramente**; 2 = **Algún tiempo / A veces**; 3 = **Gran parte del tiempo / Frecuentemente**; 4 = **Casi siempre / Siempre**.
- **Ítems Directos (10 ítems patológicos):** Ítems 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15 y 19. Se computan con el valor directo marcado (1, 2, 3 o 4 puntos).
- **Ítems Inversos (*) (10 ítems positivos de bienestar):** Ítems 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 20.
 - Se invierte su valor antes de sumar: **1 = 4 puntos | 2 = 3 puntos | 3 = 2 puntos | 4 = 1 punto**.
- **Puntuación Bruta Total:** Suma de las puntuaciones corregidas de los 20 ítems (rango posible: 20 a 80 puntos).
- **Índice de Depresión de Zung (Índice SDS):** En algunos contextos anglosajones se traslada a un índice porcentual estandarizado mediante la fórmula: $\text{Índice SDS} = \frac{\text{Puntuación Bruta}}{80} \times 100$ (rango: 25 a 100).

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Bruta	Categoría Clínica	Significación Psicopatológica y Manejo Terapéutico
20 – 35 puntos (Índice < 50)	Rango Normal / No Deprimido	Variaciones normales del estado de ánimo sin significación clínica. No requiere intervención farmacológica.
36 – 51 puntos (Índice 50 – 59)	Depresión Leve a Moderada	Distimia o depresión menor reactiva. Malestar psicosocial leve. Psicoterapia de apoyo o cognitivo-conductual.
52 – 67 puntos (Índice 60 – 69)	Depresión Moderada a Grave	Umbral clínico formal. Episodio depresivo mayor confirmado. Requiere tratamiento antidepresivo y seguimiento médico.
68 – 80 puntos (Índice ≥ 70)	Depresión Grave / Muy Grave	Sintomatología depresiva masiva, anhedonia profunda y grave compromiso vital. Valorar hospitalización psiquiátrica.

UMBRAL DE DECISIÓN ASISTENCIAL (CONDE ET AL., 1970): Una puntuación bruta ≥ **52 puntos** (o Índice SDS ≥ **60**) representa el punto de corte con mayor validez de criterio para diagnosticar un Episodio Depresivo Mayor que exige instauración inmediata de tratamiento médico y psicoterapéutico.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Cribado en consulta general o comunitaria:

- Administrar la SDS ante pacientes con quejas somáticas vagas (astenia, cefaleas, insomnio, estreñimiento) o tristeza reactiva.

Paso 2: Examen directo del Ítem 19 (Ideación de muerte):

- Si el **Ítem 19** ≥ 2 ("Creo que sería mejor para los demás si me muriera"): Detener la valoración rutinaria y realizar exploración psicopatológica inmediata de riesgo e intencionalidad autolítica activa.

Paso 3: Vía terapéutica recomendada según estratificación:

- **SDS ≤ 35 :** Tranquilización, refuerzo de pautas de estilo de vida saludable y alta del programa de cribado.
- **SDS 36 – 51:** Intervención psicoeducativa, activación conductual y reevaluación ambulatoria en 4 semanas.
- **SDS 52 – 67:** Inicio de antidepresivo de primera línea (ISRS como Sertralina o Escitalopram) coordinado con psicoterapia cognitivo-conductual.
- **SDS ≥ 68 :** Derivación preferente o urgente a Psiquiatría. Descartar síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo (delirios de ruina/culpa).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 61 años, contable prejubilado, consulta a su médico de atención primaria por astenia intensa de 3 meses, pérdida de 5 kg de peso involuntaria, estreñimiento pertinaz e incapacidad para disfrutar de sus nietos.

Resultados en la Escala SDS de Zung y Conde:

- **Puntuación Bruta Total: 58 puntos / 80** (Índice SDS = 72.5% -> Depresión Moderada a Grave).
- Ítems somáticos alterados: Ítem 4 = 4 (insomnio terminal), Ítem 5* = 4 invertido (anorexia severa), Ítem 7 = 3 (adelgazamiento), Ítem 10 = 4 (astenia severa).
- Ítems afectivos/cognitivos: Ítem 1 = 3 (tristeza constante), Ítem 11* = 3 invertido (pensamiento enlentecido), Ítem 14* = 4 invertido (pesimismo absoluto sin esperanza), Ítem 17* = 4 invertido (se percibe una carga para su familia), Ítem 19 = 2 (ideación pasiva de muerte).

Formulación y Tratamiento: Se descartó patología orgánica digestiva mediante analítica completa. La SDS permitió clarificar que los síntomas gastrointestinales y el adelgazamiento eran la expresión biológica de un Episodio Depresivo Mayor. Se inició tratamiento con Mirtazapina 30 mg nocturnos (para actuar simultáneamente sobre insomnio, apetito y ánimo) asociado a psicoterapia de activación conductual. A las 6 semanas, la puntuación bruta en la SDS descendió a 33 puntos, con normalización del peso y recuperación del descanso nocturno.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS CLÍNICAS CRÍTICAS:

- **Peso somático elevado en ancianos:** La SDS contiene 8 ítems biológicos (40% de la escala). En pacientes geriátricos o con pluripatología médica crónica, la puntuación puede sobreestimarse por enfermedad orgánica.
- **Omisión en ítems inversos:** Verificar que el paciente no haya respondido "1" en toda la columna sin leer, lo que invalidaría la prueba.
- **Riesgo de suicidio (Ítem 19):** Obliga a indagar letalidad y plan estructurado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Pseudodemencia depresiva:** En ancianos con confusión (ítem 11) y apatía (ítem 12), diferenciar entre demencia incipiente y depresión mediante screening cognitivo (MMSE).
- **Trastorno por Ansiedad Generalizada:** En el TAG predomina la aprensión futura y tensión motora, mientras que en la SDS destaca la anhedonia y el enlentecimiento psicomotor.
- **Duelo no complicado:** Tristeza reactiva proporcional a una pérdida sin la culpa patológica o inutilidad global de la depresión mayor.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Zung, W. W. K. (1965). A self-rating depression scale. *Archives of General Psychiatry*, 12(1), 63–70. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1965.01720310065008>
2. Conde López, V., Escrivá, J. A., & Izquierdo, J. (1970). Evaluación estadística y adaptación de la escala autoaplicada para la depresión de Zung. *Archivos de Neurobiología*, 33(3), 281–303.
3. Conde, V., & Franch, J. I. (1984). *Escala de evaluación comportamental para la cuantificación de la sintomatología psicopatológica en los trastornos angustiosos y depresivos*. Upjohn.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.